

### Información Paciente

**Nombre** : Andrea Berenice Carrasco Cortes  
**Edad** : 33a 11m 8d  
**Dirección** : Francisco Coloane 01377

**Rut** : 18.317.331-6  
**Fecha Nacto**: 17/04/1992  
**Comuna** : Puente Alto

**N° Archivo** : 2432614  
**Sexo** : Femenino  
**Teléfono** : 9 5232 2297

**N° Epicrisis**  
**476484**

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Pre-Hospitalización

**Fecha Ingreso** : 23/03/2026 17:42

**Días Estadía** : 2

**Unidad de Egreso** : Pre-Hospitalización

**Fecha Egreso** : 25/03/2026 20:03

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Shock hipovolémico

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

#### Antecedentes

- AM: DMtipo1, múltiples CAD severas, sin adherencia a terapia. Monorrena x nefrectomía x absceso renal
- Fcos: tojueo + novorapid
- Alergias: aparente rx adversa a ceftriaxona pero post sin RAM

Paciente conocida por DM1 con múltiples CAD severas e hipoglicemias. Traída en ambulancia. Ingresó en shock hipovolémico. Quejumbrosa. Sin VVP por mal acceso.

Se conecta a monitor y se observan complejos anchos sin onda P con FC 150lpm aprox. Paciente deja de quejarse, sin respuesta a estímulo doloroso. Pulsos inicialmente no palpables pero luego disminuidos.

Se traslada a REA por posible fibrilación ventricular.

Ingresó en malas condiciones generales, hipotensa, taquicárdica, mal perfundida, llene capilar en 4 seg, mottling 2, comprometida de conciencia, sopor profundo

Impresiona nuevo episodio de CAD, ingresa a REA para CVC

Realizado al primer intento YD.

Se hospitaliza

#### Laboratorio

- Lab 24/03 control: pH 7.48 PCO2 40.7 HCO3 29.6 ELP 139/4.0/104
- Lab 24/03: Crea 1.18, BUN 51.2, ELP 146/3.82/107, GSV pH 7.42 pCO2 43 HCO3 27.8
- Lab 24/03 01:13: K 3.57, pH 7.4, BIC 16.8, glucosa 697
- Lab ingreso: lactico 44.9 urico 17.7 biliT/D 0.24/0.15 FA 176 GGT 29 GOT 30 GPT 20 Ca 8.3 Crea 3.38 BUN 107.3 gluc 1595 LDH 264 Mg 4.1 prot 7.3 PCR 34.7, ELP 124/7.5/73 Hb 11.4 GB 17.340 PLQ 466.000 pH 6.96 PCO2 20 HCO3 4.5 EB -27.4 cetonas en orina +++ OC inflamatoria UC polimicrobiano

#### Imágenes

**Fecha Epicrisis** : 25/03/2026 20:12

Fecha Última Actualización: 25-03-2026 20:12:49

Página 2 de 3

Angiotac Tx: Examen sin evidencia de TEP agudo. Tronco de arteria pulmonar dilatado hasta 35 mm. Signos de bronconeumopatía bilateral, de predominio bibasal, probablemente infecciosa inflamatoria. Bronquielectasias bibasales, más evidente a izquierda. Múltiples adenopatías mediastínicas reactivas.

### Diagnósticos de ingreso

1. CAD
2. Shock hipovolémico resuelto
3. NAC
4. AKI KDIGO I en resolución
5. Antecedentes: DM1, monorrea

### Evolución durante hospitalización

- HDN: Paciente ingresa en shock hipovolémico. Al monitor se observan complejos anchos sin onda P con FC 150 lpm aprox, sin respuesta a estímulos dolorosos. Pulsos inicialmente no palpables, posteriormente débiles. Evoluciona con hemodinamia estable, autosostenida, manteniendo tendencia a al hipotensión y taquicardia hasta 135 lpm. Se instala CVC por dificultad de acceso a VVP. Se solicita AngioTAC Tx que descarta TEP. Actualmente HDN estable, normocárdica y normotensa.
- Metabólico: Paciente ingresa con shock hipovolémico y compromiso de consciencia secundario a CAD/SHH, glicemias de 1550 y cetonas +++. Se inicia protocolo CAD con buena evolución, actualmente con criterios de resolución, con traslape a insulina SC manteniendo HGT dentro de rango. Buena tolerancia oral. Al alta paciente NO debe irse con NPH/cristalina, sino que debe mantener esquema habitual (último esquema 13/03 Toujeo 4U AM, novorapid preprandial según esquema entregado por equipo tratante).
- Respiratorio: Ingresa con altos requerimientos de oxígeno, hasta 12 L con MAF, por lo que se sospecha de NAC aspirativa en contexto de compromiso de conciencia y se inicia ampicilina/subactam. En paralelo, considerando altas frecuencias cardíacas y requerimientos de oxígeno, solicito angioTAC de tórax buscando TEP que se descarta. Suspende O2 suplementario ayer a las 23:00.
- Infeccioso: cursando NAC e ITU, en tratamiento ATB con ceftriaxona para cubrir ambos focos.

### Indicaciones:

Regimen diabetic

Habitos alimenticios a horario

Levofloxacin 500 mg. 1 comprimido cada 24 horas por 7 días VO

Insulina Toujeo (blanco y verde) = 4 unidades en la mañana

Insulina Novorapid antes de las comidas según tabla entregada por diabetología

B. Ipatropio 4 puff sos

Paracetamol 1g cada 8h por 5 días

Mantener medicamentos de uso crónico

Mantener controles con diabetología

Acudir a SU en caso de compromiso de conciencia, fiebre, dificultad para respirar, o en caso que estime conveniente

### Diagnóstico de Egreso

Cetoacidosis diabética -

**Condición de Egreso** Alta Domicilio

**Egreso con Catéter Doble J:NO**

Buenas condiciones generales, HDN estable, sin req O2 suplementario, afebril.

### Plan Post Alta

Indicaciones:

Regimen diabetic

Habitos alimenticios a horario

Levofloxacin 500 mg. 1 comprimido cada 24 horas por 7 días VO

Insulina Toujeo (blanco y verde) = 4 unidades en la mañana

Insulina Novorapid antes de las comidas según tabla entregada por diabetología

B. Ipatropio 4 puff sos

Paracetamol 1g cada 8h por 5 días

Mantener medicamentos de uso crónico

Mantener controles con diabetología

**Fecha Epicrisis : 25/03/2026 20:12**

Página 2 de 3

# Epicrisis Hospitalaria

## ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 25-03-2026 20:12:49

Página 3 de 3

Acudir a SU en caso de compromiso de conciencia, fiebre, dificultad para respirar, o en caso que estime conveniente

### Indicaciones

**Tipo de Reposo** : Relativo

**Régimen Alimentario** : Con 50 G De Hidratos De Carbono Cada 6 Horas

**Medicamentos** :

### Controles

INTERNO

Becado/Residente



Maria José Figueroa Sepulveda  
Médico Tratante (Staff)